

QCM1: L'angine de l'enfant :

- A. Est le plus souvent d'origine streptococcique
- B. Justifie un traitement antibiotique systématique
- C. Peut être révélée par une symptomatologie digestive
- D. Expose au risque des complications suppuratives
- E. Indique la réalisation d'un TDR avant l'âge de 3ans

QCM2: L'angine à Streptocoque bêta-hémolytique du groupe A :

- A. Est plus fréquente chez l'enfant en âge préscolaire
- B. Justifie un traitement antibiotique systématique
- C. S'accompagne des signes rhinologiques et respiratoires
- D. Est le plus souvent de type érythémato pultacée
- E. Expose au risque de rhumatisme articulaire aigu

QCM3: L'angine pseudo membraneuse peut se voir lors de :

- A. La mononucléose infectieuse
- B. scarlatine
- C. La diphtérie
- D. L'infection par le streptocoque B hémolytique A
- E. Herpangine

QCM4: Les signes cliniques orientant vers l'origine virale d'une angine sont :

- A. l'âge inférieur à 3 ans
- B. La Fièvre élevée
- C. La présence d'adénopathies cervicales multiples
- D. La présence des vésicules
- E. L'association à un herpès labial

QCM5: L'angine de Vincent :

- A. Est de type érythémateuse
- B. Est fréquente chez l'enfant
- C. S'accompagne des signes généraux marqués
- D. De cause bucco-dentaire
- E. Justifie une antibiothérapie

QCM6: Une antibiothérapie est systématique dans :

- A. l'angine streptococcique
- B. L'herpangine
- C. La Mononucléose infectieuse
- D. L'angine fuso spirillaire
- E. La diphtérie

QCM7: La ou les affections suivantes peuvent être responsables d'une angine ulcéro nécrotique :

- A. La syphilis
- B. La diphtérie
- C. L'Angine de vincent
- D. Le cancer de l'amygdale
- E. Une hémopathie

QCM8: Chez enfant âgé de 6 ans, sans antécédents particuliers, présentant une angine d'origine streptococcique, le(s) traitement(s) suivant(s) sont préconisés de 1^{ère} intention :

- A. Amoxicilline (50mg/kg/j) pendant 6 jours
- B. Paracétamol
- C. Anti inflammatoire non stéroïdien
- D. Azithromycine
- E. Corticothérapie par voie générale

QCM9: Parmi les complications locorégionales de l'angine, on retient :

- A. La cellulite cervicale
- B. Le choc toxinique
- C. Le Phlegmon péri amygdalien
- D. L'adénophlegmon
- E. Le Syndrome de Lemière

QCM10: concernant la scarlatine :

- A. L'angine est érythémateuse
- B. L'énanthème est constant
- C. L'agent causal est le streptocoque type A
- D. La durée d'incubation est de 3 semaines
- E. L'exanthème respecte des intervalles de peau saine

QCM11: une angine érythémateuse peut se voir au cours de :

- A. La scarlatine
 - B. Herpangine
 - C. SIDA
 - D. Mononucléose infectieuse
 - E. Covid 19
-

QCM1: Les 3 principaux germes incriminés dans l'étiopathogénie de l'OMA sont :

- A. Haemophilus influenza
- B. Pseudomonas Aeruginosae
- C. Streptocoque bêta hémolytique du groupe A
- D. Streptocoque pneumoniae
- E. B. catarrhalis

QCM2: L'otite moyenne aiguë (OMA) :

- A. Est plus fréquente chez l'adulte
- B. Peut être révélée par une symptomatologie digestive chez l'enfant
- C. Est le plus souvent d'origine virale
- D. Impose un traitement antibiotique systématique chez l'enfant
- E. Indique la réalisation d'une paracentèse

QCM3: Les complications possibles d'une OMA sont :

- A. La paralysie faciale centrale
- B. Le syndrome de Lemière
- C. La mastoïdite aiguë
- D. La méningite
- E. La labyrinthite

QCM4: Une antibiothérapie est indiquée chez un enfant âgé de 3 ans présentant une otalgie intense avec fièvre devant :

- A. Une otite congestive
- B. Une otite associée à une conjonctivite
- C. Une Otite collectée
- D. Une otite séromuqueuse
- E. Otorrhée purulente

Cas clinique QCM: Nourrisson âgé de 8 mois amené aux urgences pédiatriques par ses parents pour fièvre avec pleurs incessants. A l'examen, fébrile à 39°, tuméfaction rétro auriculaire gauche inflammatoire de 4 cm décollant le pavillon. L'otoscopie montre un tympan congestif bombant en postéro supérieur à gauche, et complet normal à droite,

1/ Le diagnostic le plus probable est :

- A. Une Mastoïdite aigüe
- B. Une cellulite cervicale
- C. Une Otite collectée
- D. Une Péri chondrite
- E. Un adénophlegmon

2/ Les examens complémentaires à demander sont :

- A. Une Numération formule sanguine
- B. Des Prélèvements bactériologiques
- C. Une TDM cérébrale injectée
- D. Une CRP
- E. Une Échographie cervicale

3/ Votre conduite thérapeutique doit comporter :

- A. Hospitalisation
 - B. Corticothérapie générale
 - C. Antibiothérapie parentérale
 - D. Paracentèse
 - E. Drainage chirurgical
-

QCM1: La sinusite maxillaire aigüe :

- A. Est le plus souvent d'origine rhinogène
- B. Se manifeste par une douleur pulsatile sous orbitaire
- C. Indique la réalisation d'un scanner des sinus
- D. Est la plus pourvoyeuse des complications orbitaires
- E. Justifie une méatotomie moyenne

QCM2: On retiendra en faveur d'une sinusite maxillaire bactérienne les éléments suivants :

- A. Douleur sus orbitaire pulsatile
- B. Fièvre > 10 jours
- C. La présence de pus au niveau du méat moyen
- D. Comblement du sinus maxillaires à la TDM du massif facial
- E. Rhinorrhée séreuse

QCM3: La (les) forme(s) clinique (s) suivante(s) indiquent la réalisation d'une TDM du massif facial :

- A. Ethmoïdite aigüe extériorisée
- B. Sinusite hyperalgique
- C. Sinusite sphénoïdale aigüe
- D. Sinusite frontale aigüe
- E. Sinusite maxillaire aigüe

QCM4: La sinusite maxillaire chronique unilatérale :

- A. Est de traitement exclusivement médical
- B. Est définie par une persistance des signes cliniques pendant plus que 3 semaines
- C. Indique la réalisation d'une TDM du massif facial
- D. Indique une méatotomie moyenne
- E. Est le plus souvent d'origine dentaire

QCM5: Parmi les causes de sinusite chronique bilatérale, on retient :

- A. La dyskinésie ciliaire
 - B. Une cause dentaire
 - C. La mucoviscidose
 - D. Une polypose nasosinusienne
 - E. Une déviation de la cloison nasale
-

QCM1: La laryngite aigüe sous glottique de l'enfant :

- A. Se manifeste par une bradypnée inspiratoire
- B. Est d'origine bactérienne
- C. Nécessite une corticothérapie en urgence
- D. Est la plus fréquente des laryngites de l'enfant
- E. Indique un scanner en urgence

QCM2: L'épiglottite de l'enfant :

- A. Indique une trachéotomie en urgence
- B. Est causée par l'*Haemophilus Influenzae*
- C. Impose un examen rapide au nasofibroscope
- D. Peut mettre en jeu le pronostic vital
- E. Réalise des micro abcès de l'épiglotte

QCM3: Parmi les facteurs favorisant les laryngites récidivantes de l'enfant, on retient :

- A. L'anémie
- B. Le tabagisme passif
- C. L'atopie
- D. Les malformations laryngées
- E. Le reflux gastro œsophagien

Cas clinique QCM4: Vous recevez aux urgences un enfant âgé de 4 ans pour dyspnée laryngée aigüe. L'examen physique montre une fièvre à 39°, une hyper salorrhée et altération de l'état général.

1/ Quel serait le diagnostic le plus probable?

- A. Une Angine érythémato pultacée
- B. Une laryngite aigüe sous glottique
- C. Un phlegmon péri amygdalien
- D. Une épiglottite
- E. Laryngite spasmodique

2) Quel serait le germe en cause ?

- A. Streptocoque B hémolytique du groupe A
- B. Virale
- C. *Haemophilus influenza*
- D. Staphylocoque aureus
- E. *Moraxella catarrhalis*

3) Quelle serait votre conduite ?

- A. Examen de l'oropharynx à l'abaisse langue
- B. Intubation en milieu de réanimation
- C. Nébulisations de corticoïdes
- D. Nasofibroscopie souple
- E. Antibiothérapie parentérale